

NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : Kamis / 18 April 2024
 Pukul : 10.00 WIB – SELESAI
 Materi : Laporan Bulanan Maret
 Tempat : Hall Sakura Lantai 5

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Waktu tunggu Antrian Online	Strategi perbaikan waktu tunggu di PHS	1. Memperbaiki pos pos di farmasi contohnya: - Pos input → bisa di cut saat penerimaan awal karena yang menjadi masalah adalah ketika resep sudah di claim oleh poli. Apabila resep sudah di cetak berarti antrian online sudah terselesaikan	Manajerial dan Farmasi
2.	Perbaikan untuk PHS	1. Target tiap unit harus ada disesuaikan dengan program kerja. Laporan di konsistenkan 2. Humas marketing dan PKRS ada perbedaan tugas 3. OK Utilitasi saat malam hari apakah sudah di atur dan apakah tidak ada antrian 4. Di Lorong bersih tidak boleh ada barang tetapi masih banyak tumpukan alkes dan aldok dan kardus kardus 5. Peningkatan pasien di PHS harus hati-hati karena kepuasan pasien justru menurun. Harus di perhatikan	1. Sistematika pelaporan harus di seragamkan dan menjadi tanggung jawab direktur (aka nada perubahan sistematika) 2. Humas dan Marketing meningkatkan jumlah kunjungan sedangkan PKRS tupoksi nya untuk promosi di dalam RS 3. Akreditasi: - Mutu: SKP masingmasing harus ada jumlah nya 6 disesuaikan dengan PMK - PPRA kembali ke prognas, pkpo kembali di PCC	Manajerial RS, Humas Marketing, PKRS dan Tim Akreditasi
		1. Klaim 2. Stock Opname Farmasi dan billing yang dikeluarkan ke pasien terdapat - No register obat keluar dua	1. Buat aturan setelah bertemu DPJP tentang STT kapan bisa dilakukan di RS. Karena bisa mempengaruhi risiko klaim	Manajerial RS, Manajerial PT, Konsultan PT Farmasi, Kasir dan Asuransi Center

	3. Crosscheck di billing rajal di pasien yang sama tercatat total habis 200.000 setelah di crosscheck di penjamin hanya 80.000. Di simrs rajal tidak ada obat yang diretur. Terdapat pdf yg berbeda beda. Fungsi dari cetak kwitansi yg berubah ubah ini apa?	2. Pada survey lapangan coba bandingkan laporan SO dengan hasil billing: - Jangan sampai melakukan kecurangan -> harus ada audit dari keuangan PT - IT jangan membuat peluang kepada human yang tidak memiliki wewenang untuk diberikan akses. - Minggu depan agendakan ZM dengan pak puguh terkait hasil auditnya seperti apa. - Harus ada barrier pertama dari dokter spesialis 3. Tindak lanjut: - Bisa dimasukkan dalam obat dengan similar apotek online-> di buat data base di simrs (bisa dilakukan di SIMRS selama rumusan sudah jelas maka di aplikasi bisa dibatasi sesuai dengan rumusan tersebut) - Obat bisa berubah selama belum ada verifikasi dari kasir dan asuransi center -> jangan dilakukan oleh asuransi center tetapi hanya kasir	
	1. Proporsi untuk dr bedah 2. Klaim bukan faktor tunggal → harus ada fokus lain 3. Double Register	1. Perlu tindakan esktrim contoh: BMHP lebih murah, cara membangun RS yang low cost 2. Wajar terjadi double register kebanyakan kejadian dikarenakan ketidaksengajaan.	Direksi RS dan Manajerial RS
	Catatan untuk PHS	1. Tambahan kamar menyesuaikan dengan kebutuhan RS	Manajerial RS

			2. Poli malam bisa menjadi pilihan untuk dokter dokter baru 3. Mengurangi kepadatan operasi bisa dilaksanakan di luar jam praktek (jam malam) agar tidak terjadi penumpukkan pasien di malam 4. ERM harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. 5. Audit harus dilaksanakan dan punishment di sesuaikan.	
3.	Laporan Kunjungan RJ	1. Strategi untuk menaikan pasien di RJ 2. Apakah dari pasien baru? 3. Apakah pasien lama ini termasuk KNS?	1. Strategi terbantu dengan Humas terbaru, penjadwalan kunjungan ke fktp dan bidan bidan yg baru maupun perusahaan 2. Bukan pasien baru tetapi peningkatan pasien lama. Program-program dan kepuasan pasien yang dilayani dengan adanya komunitas komunitas sehingga ada peningkatan pada pasien lama 3. Perhatikan juga Rujuk Balik. (sudah dapat feedback dan di breakdown kasus kasus itu sudah menjadi spesialisik) harus ada standar disesuaikan PMK.	Manajerial RS dan Humas Marketing
4.	Perbaikan untuk PHM	1. Mutu 2. Neonatologi 3. Keterampilan SDM IGD 4. Kabid	1. SKP harus dipenuhi semua 2. PPK CP untuk Neonatologi harus ada. PPK CP untuk SMF yang belum punya bisa disegerakan 3. Perlu tau keterampilan dari IGD terkait penanganan pasien meninggal 4. Kabid harus lebih peka dan by data	Manajerial RS dan SDM RS
		1. Data yang ditampilkan terkait kinerja OK 2. Customer Segment	1. Bandingkan tiap tindakan besar kecil sedang sama khusus. Microtizing facitis masih di temukan di laporan asuransi center	Direksi RS dan Manajerial RS

		a) Kenapa menggunakan umum?	sehingga klaim lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. 2. Customer Segment: a) Sudah pernah mengajukan ke BPJS tetapi masih ada beberapa aturan. Setelah siap baru bisa berkoordinasi dengan asuransi apa saja yang bisa menggunakan poli eksekutif. b) Jadwal apakah sudah di koordinasikan? Jangan sampai beririsan dengan HFIS harus segera pengajuan (sudah disesuaikan HFIS nya tidak beririsan dengan poli eksekutif)	
5.		Catatan untuk kedua RS	1. Informasi terkait utilitas bisa dipecah agar bisa tau jenis pelanggannya seperti apa. Di detailkan lagi analisisnya untuk dapat mengetahui karakteristik pasien. Sehingga bisa mengetahui strategi strategi apa yang bisa dilakukan RS 2. Tidak ada satu strategi spesifik untuk meningkatkan kunjungan	Direksi RS dan Manajerial RS
6.	Penambahan ruangan	1. Tindakan kulit yang tidak bisa di lakukan di ruang operasi	1. Harus ada ruang tindakan di poli. Manajemen mulai memproyeksikan ruangan yang masih belum terpakai untuk di gunakan sebagai ruang Tindakan	Direksi RS
7.	Programmer	1. Sarana dan prasarana 2. Harus tau skala prioritas dengan eksternal	1. Apabila diperlukan penggantian untuk menunjang kelancaran bisa langsung dilakukan pengajuan dan penunjukkan PIC 2. SIMRS berikan yang terbaik sehingga apapun yang menjadi kekurangan	Manajerial RS, PT dan Programmer

			harus segera di tangani secara maksimal dan koordinasikan dengan direktur	
--	--	--	--	--

Pemimpin Rapat



dr. Sadi Hariono, MMRS

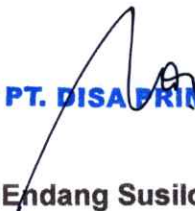
Malang, 18 April 2024

Notulis



Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika


 PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati

DOKUMENTASI

